PUSTAKA MODUL AHLI KERTAMARGA BALI | KODE MATKUL: KEP203 | ID: PDF-KES-02

# Buku Ajar & Praktikum: Enam Sasaran Keselamatan Pasien (SKP), Pencegahan Infeksi (PPI), Komunikasi SBAR & Asuhan Caregiver

**Kategori Dokumen:** Modul Keselamatan Pasien & Asuhan • **Standar Sertifikasi:** Standar Akreditasi RS Kemenkes & BNSP Caregiver Q.86.CGL
**Penyusun & Referensi:** Tim Kurikulum Mutu Klinis & Keperawatan KertaMarga
**Rujukan Dokumentasi Eksternal:** https://www.who.int/teams/integrated-health-services/patient-safety
**Lokasi Penyimpanan Terpusat:** `public/pustaka-modul/05-kesehatan/MODUL-KES-02-Keselamatan-Pasien-SKP-Pencegahan-Infeksi-SBAR-dan-Caregiver.pdf`

---

**Ringkasan Eksekutif Modul:** Implementasi 6 Sasaran Keselamatan Pasien (SKP), 5 Momen Cuci Tangan WHO, pelaporan klinis terstruktur SBAR, serta pencegahan dekubitus pada lansia.

## BAB 1: Enam Sasaran Keselamatan Pasien (SKP), 5 Momen Hand Hygiene & SBAR

Keselamatan pasien (Patient Safety) mencegah terjadinya Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) dan Kejadian Nyaris Cedera (KNC). Enam Sasaran Keselamatan Pasien wajib diterapkan di setiap fasilitas layanan kesehatan: (1) Mengidentifikasi pasien dengan benar menggunakan minimal 2 identitas (Nama Lengkap dan Tanggal Lahir/Nomor RM, dilarang menggunakan nomor kamar), (2) Meningkatkan komunikasi efektif antar-nakes dengan metode SBAR dan TBAK (Tulis-Baca-Konfirmasi), (3) Meningkatkan keamanan obat High-Alert dan LASA (Look-Alike Sound-Alike), (4) Kepastian tepat-lokasi, tepat-prosedur, tepat-pasien operasi (Time-Out), (5) Pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan (HAIs), dan (6) Pengurangan risiko cedera pasien akibat jatuh (Skala Morse/Humpty Dumpty).

```
TEMPLATE KOMUNIKASI EFEKTIF SBAR (SITUATION - BACKGROUND - ASSESSMENT - RECOMMENDATION):
- S (Situation)     : Identitas pelapor, nama & tgl lahir pasien, keluhan utama saat ini.
- B (Background)    : Diagnosis medis masuk, riwayat alergi, terapi/tindakan yang sudah diberikan.
- A (Assessment)    : Hasil TTV terkini, skor NEWS2, skala nyeri, dan analisis masalah klinis.
- R (Recommendation): Usulan intervensi spesifik atau permintaan instruksi dokter segera.
```

---

## BAGIAN LANJUTAN: URAIAN LENGKAP MODUL KURIKULUM & PRAKTIKUM MATA KULIAH (KEP203)

### Modul 1 [KES.VK01.003 - Semester 2 / Standar UKOM & Akreditasi RS]: Modul 3: Enam Sasaran Keselamatan Pasien (SKP) & Komunikasi Efektif SBAR (Menengah - 55 Menit)

**Ringkasan Kompetensi:** Memahami prosedur wajib rumah sakit dan klinik agar pasien terhindar dari insiden keselamatan medis.

**Konsep Inti yang Wajib Dikuasai:**

1. SKP 1 - Ketepatan Identifikasi Pasien: Minimal 2 identitas resmi (Nama Lengkap & Tanggal Lahir/No. Rekam Medis, dilarang menggunakan nomor kamar)
2. SKP 2 - Komunikasi Efektif SBAR (Situation, Background, Assessment, Recommendation) dan metode TBAK (Tulis, Baca, Konfirmasi Ulang) via telepon
3. SKP 3 s.d. 6: Keamanan Obat High-Alert, Kepastian Tepat-Lokasi/Tepat-Prosedur Operasi (Site Marking), Pengurangan Risiko Infeksi, dan Pencegahan Pasien Jatuh (Gelang Kuning)
4. Dokumentasi Asuhan Keperawatan: Pengkajian, Diagnosis (SDKI), Intervensi (SIKI), Implementasi, dan Evaluasi SOAP (SLKI)

**Uraian Materi Mendalam:** Uji Kompetensi Nasional (UKOM) Keperawatan sangat menekankan keselamatan pasien dan penggunaan standar SDKI-SLKI-SIKI PPNI. Sebelum melakukan tindakan invasif atau pemberian obat, perawat wajib mencocokkan gelang identitas pasien (Biru untuk laki-laki, Merah Muda untuk perempuan, Merah untuk alergi, Kuning untuk risiko jatuh).

**Studi Kasus Industri & Implementasi Bali:** Studi Kasus Bali: Penerapan komunikasi SBAR dwibahasa (Indonesia-Inggris) pada rumah sakit rujukan wisata medis internasional di Denpasar dan Sanur.

```
Instruksi Praktikum Mandiri: Susun kalimat laporan singkat menggunakan format SBAR untuk melaporkan pasien dengan suhu tubuh 39.1 C dan tekanan darah 90/60 mmHg kepada dokter jaga.
```

### Modul 2 [KES.PG02.012 - Semester 2 / Pencegahan Infeksi (PPI)]: Modul 4: Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI), Sterilisasi & Manajemen Limbah Medis (Terapan - 50 Menit)

**Ringkasan Kompetensi:** Memutus rantai penularan infeksi nosokomial (HAIs) di fasilitas pelayanan kesehatan.

**Konsep Inti yang Wajib Dikuasai:**

1. 5 Momen Cuci Tangan WHO: Sebelum kontak pasien, sebelum tindakan aseptik, setelah terkena cairan tubuh, setelah kontak pasien, setelah kontak lingkungan pasien
2. Dekontaminasi Alat Medis: Pre-cleaning (enzimatik) -> Pencucian -> Desinfeksi Tingkat Tinggi (DTT) / Sterilisasi Autoklaf uap bertekanan
3. Pemilahan Limbah Medis: Kantong Kuning (Infeksius/Kasa darah), Kantong Hitam (Domestik non-medis), Kantong Cokelat (Farmasi/Kedaluwarsa), dan Safety Box (Jarum suntik/Benda tajam)
4. Prinsip Aseptik & Larangan Recapping (tidak menutup ulang jarum suntik bekas dengan dua tangan)

**Uraian Materi Mendalam:** Infeksi terkait pelayanan kesehatan (Healthcare-Associated Infections / HAIs) dapat dicegah dengan kepatuhan kebersihan tangan (6 langkah cuci tangan: 20-30 detik dengan handrub berbasis alkohol atau 40-60 detik dengan air mengalir dan sabun) serta pembuangan benda tajam langsung ke dalam Safety Box.

**Studi Kasus Industri & Implementasi Bali:** Studi Kasus Bali: Standar pengelolaan limbah medis ramah lingkungan dan audit PPI pada jaringan klinik pratama serta rumah sakit daerah di Bali.

```
Instruksi Praktikum Mandiri: Jelaskan ke dalam wadah warna apa masing-masing limbah berikut harus dibuang: (1) Jarum infus bekas, (2) Kapas bekas darah pasien, dan (3) Bungkus makanan pembesuk!
```

---

## BAGIAN EVALUASI: BANK SOAL & PEMBAHASAN SERTIFIKASI (Standar Akreditasi RS Kemenkes & BNSP Caregiver Q.86.CGL)

### Soal Sertifikasi #1 [Unit Kompetensi: KES.PG01.004.01 | Skema: UKOM Nasional & Patient Safety (KES.PG)]

**Pertanyaan Kasus:** Sebelum memberikan obat injeksi kepada pasien rawat inap, prosedur identifikasi pasien manakah yang paling tepat sesuai standar Sasaran Keselamatan Pasien?

A. Menanyakan nomor kamar dan menebak nama panggilan pasien

**B. [KUNCI JAWABAN]** Memeriksa minimal dua penanda identitas resmi pada gelang pasien (Nama Lengkap dan Tanggal Lahir/Nomor Rekam Medis)

C. Langsung memberikan obat karena pasien berada di tempat tidur yang sama sejak kemarin

D. Bertanya kepada pengunjung di ruang tunggu

```
Pembahasan Teknis Asesor: Benar! Standar keselamatan pasien mewajibkan verifikasi minimal 2 identitas unik (Nama Lengkap dan Tanggal Lahir/No. RM) dan dilarang menggunakan nomor kamar atau nomor tempat tidur.
```

### Soal Sertifikasi #2 [Unit Kompetensi: KES.VK01.008.01 | Skema: UKOM Nasional & Patient Safety (KES.PG)]

**Pertanyaan Kasus:** Setelah selesai melakukan tindakan pemasangan infus pada pasien, ke manakah jarum introducer (benda tajam) dan kasa yang terkontaminasi darah harus dibuang sesuai standar PPI?

A. Keduanya dibuang ke tempat sampah plastik hitam biasa

**B. [KUNCI JAWABAN]** Jarum langsung dimasukkan ke dalam Safety Box tanpa ditutup ulang (no recapping), sedangkan kasa berdarah dibuang ke kantong plastik Kuning infeksius

C. Jarum dibuang ke kantong cokelat, kasa dibuang ke wastafel cuci tangan

D. Dicuci dengan air keran lalu disimpan di meja pasien

**Pembahasan Teknis Asesor:** Tepat! Benda tajam medis wajib langsung masuk ke Safety Box tahan tusuk tanpa recapping untuk mencegah needle-stick injury, sedangkan limbah infeksius non-tajam masuk ke kantong Kuning.